

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
02/10/2023	02/10/2025	nº 03	SES.ENF nº 09	01 à 06
Nome do Procedimento: Cateterismo vesical por cistostomia suprapúbica ou vesicostomia				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Diretoria Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária				
Serviço: Unidade Básica de Saúde da Família, Serviços Especiais e Pronto Atendimento				
Executantes: Enfermeiros e Médicos				
Objetivo: Orientar a padronização do procedimento de cateterismo vesical por cistostomia suprapúbica ou vesicostomia				
Recursos necessários: ✓ Prescrição médica; ✓ Luva estéril; ✓ Luva de procedimento; ✓ Bandeja de cateterismo vesical esterilizada: cuba rim, pinça, cuba redonda, gazes e campo; ✓ Mesa auxiliar; ✓ Sonda de <i>foley</i>; ✓ Bolsa coletora de urina estéril; ✓ Água destilada; ✓ Agulha para aspiração; ✓ 02 Seringas de 20ml <i>slip</i> (sem rosca); ✓ Fita adesiva (esparadrapo ou adesivo hipoalergênico); ✓ Gaze estéril; ✓ Clorexidina aquosa 2%; ✓ Água; ✓ Sabão; ✓ Papel toalha e/ou compressa; ✓ Biombo; ✓ Saco para lixo.				

Conceito

Cistostomia é uma derivação urinária percutânea, realizada por técnica cirúrgica, seja por punção suprapúbica ou por procedimento a céu aberto, para drenagem de urina nos casos em que a urina não pode ser eliminada pela via uretral.

Indicação

- ✓ Trauma uretral, fechado ou penetrante;
- ✓ Obstrução uretral de qualquer origem, inviabilizando a passagem de cateter por via uretral;
- ✓ Retenção urinária aguda em qualquer um dos casos acima;
- ✓ Obstrução do colo vesical;
- ✓ Estenose de uretra;
- ✓ Pós uretroplastia;
- ✓ Pós cistoplastia.



Contraindicações

- ✓ Portadores de neoplasia de bexiga, ou na suspeita de tumor vesical;
- ✓ Radioterapia.
- ✓ Cirurgias pélvicas.

Complicações

- ✓ Infecção da ferida operatória ou da punção supra púbica;
- ✓ Extravasamentos de urina no tecido perivesical, subcutâneo ou ao redor do cateter;
- ✓ Obstrução do cateter e ou deslocamento do mesmo;
- ✓ Infecção urinária;
- ✓ Incrustações calcárias ao redor do cateter;
- ✓ Perfuração do peritônio e ou alça intestinal;
- ✓ Perfuração da parede posterior da bexiga e do reto;

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Pré-inserção

- ✓ Revisar os registros do usuário, buscando a indicação do procedimento e a prescrição médica;
- ✓ Avaliar as condições do usuário: mobilidade, limitações físicas, nível de consciência, capacidade de compreensão e cooperação, padrão e última eliminação urinária, alterações geniturinárias, intercorrências ou alergias;
- ✓ Reunir todo o material necessário;
- ✓ Organizar o material sobre uma bancada, mesa auxiliar ou superfície de apoio;
- ✓ Explicar o procedimento e a finalidade ao usuário e/ou acompanhante;
- ✓ Promover ambiente iluminado e privativo, podendo ser utilizado o biombo.

Retirada do cateter

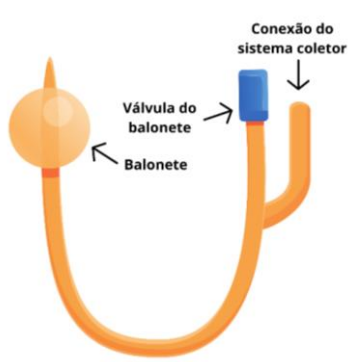
- ✓ Higienizar as mãos conforme Procedimento Operacional Padrão (POP – Rotina nº 23);
- ✓ Calçar a luva de procedimento;
- ✓ Posicionar o usuário em decúbito dorsal;
- ✓ Remover a fita de fixação da sonda, cuidadosamente;
- ✓ Abrir uma seringa de 20 ml e desinsuflar totalmente o balonete;
- ✓ Remover lentamente o cateter;
- ✓ Realizar higiene com água e sabão na região peristoma, removendo resíduo de adesivo e/ou sujidade visíveis;
- ✓ Utilizar compressa ou pano limpo para secagem das regiões higienizadas;
- ✓ Retirar a luva de procedimento;
- ✓ Higienizar as mãos conforme Procedimento Operacional Padrão (POP – Rotina nº 23).

Novo cateterismo

- ✓ Abrir a bandeja de cateterismo vesical esterilizada;
- ✓ Adicionar gaze dentro da bandeja de cateterismo vesical se necessário;
- ✓ Abrir e colocar na bandeja de cateterismo vesical esterilizada os materiais: bolsa coletora de urina estéril, sonda de *foley* com o tamanho do ostoma, 01 seringa de 20 ml com bico *slip* e agulha para aspirar a água destilada;
- ✓ Inserir a Clorexidina aquosa a 2% dentro da cuba redonda;
- ✓ Realizar a assepsia da ampola da água destilada, abrir o lacre e posicionar a ampola de modo que seja possível aspirar o conteúdo de forma fácil;

- ✓ Higienizar as mãos conforme Procedimento Operacional Padrão (POP – Rotina nº 23);
- ✓ Calçar as luvas estéreis;
- ✓ Conectar a agulha na seringa *slip* e aspirar a água destilada na quantidade indicada pelo fabricante, descrito no conector da sonda de *foley*;
- ✓ Desconectar a agulha, e conectar a seringa na válvula do balonete para testar a integridade, insuflando a água aspirada;

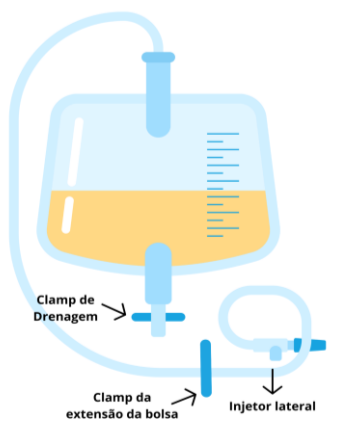
Figura 01 – Descritivo técnico da sonda foley



Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial, 2023

- ✓ Desinsuflar o balonete aspirando totalmente o conteúdo injetado;
- ✓ Conectar a sonda de *foley* na bolsa coletora de urina estéril, e não a desconectar para manter o sistema fechado;
- ✓ Manter aberto o *clamp* da extensão da bolsa de drenagem e fechar o *clamp* de drenagem;

Figura 02 – Descritivo técnico da bolsa coletora

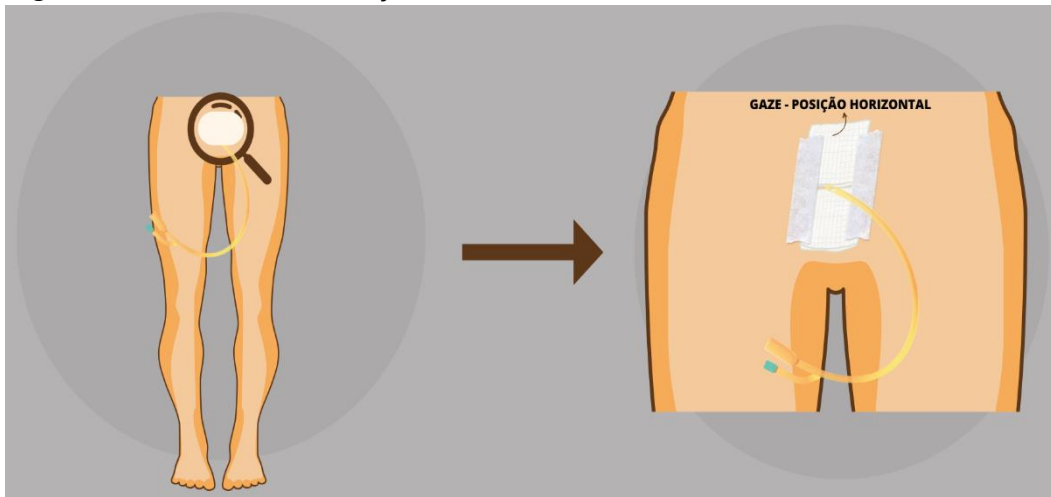


Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial, 2023

- ✓ Realizar a antisepsia, com a mão dominante, ao redor do ostoma com movimento circular, de dentro para fora, desprezando a torunda utilizada a cada movimento;
- ✓ Colocar o campo fenestrado estéril sobre o abdome, de modo que o ostoma fique no centro da fenestra;
- ✓ Introduzir a sonda delicadamente no estoma, cerca de 10 cm, observar a presença de diurese;
- ✓ Insuflar o balonete com água destilada de acordo com a recomendação do fabricante,
- ✓ Tracionar lentamente a sonda até sentir resistência;
- ✓ Retirar o campo estéril;

- ✓ Secar a pele do abdome com compressa ou gaze;
- ✓ Proteger o ostoma com gaze, de modo que a sonda fique perpendicular ao abdome (dobre 8 gazes no meio, dois blocos de 4 gazes, e posicione cada bloco em um dos lados da sonda, de modo que sonda permaneça no centro, fixando com fita adesiva em toda a extensão da gaze, e estabilizando a sonda no centro);

Figura 03 – Modo de realização do curativo de cistostomia

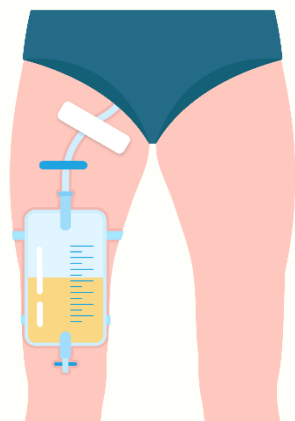


Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial, 2023

Pós procedimento

- ✓ Posicionar a bolsa coletora de urina estéril abaixo do nível da bexiga;

Figura 04 – Posicionamento da bolsa coletora



Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial, 2023

- ✓ Aguardar a drenagem da urina, observar o volume total drenado e as características da urina;
- ✓ Auxiliar o usuário a se vestir e/ou coloque a fralda descartável;
- ✓ Recolher o material utilizado, e descartar conforme o Procedimento Operacional Padrão (POP – Rotina nº 38);
- ✓ Desprezar as luvas;
- ✓ Identificar a bolsa coletora de urina estéril com data, número da sonda, volume injetado no balonete, nome do profissional;
- ✓ Higienizar as mãos conforme procedimento operacional padrão (POP – Rotina nº 23);
- ✓ Orientar usuário sobre os devidos cuidados com a sonda e período para troca, se

- necessário;
- ✓ Registrar o procedimento no Sistema de Gestão Integral (SIG-Saúde Tech).

Troca e retirada da sonda vesical de demora

Não há um consenso técnico quanto ao intervalo fixo de troca, porém, indica-se a média para substituição de 21 dias.

Deve ser realizada a troca do sistema quando houver:

- ✓ Incrustações, resíduos, depósitos ou sujeira no trajeto da sonda e bolsa coletora de urina estéril;
- ✓ Sinais de infecção urinária (púls, grumos, odor fétido, dor no trajeto da sonda, dor em região suprapúbica, dor lombar recorrente, febre);
- ✓ Perfurações, rasgos, vazamentos ou danos ao sistema;
- ✓ Desconexão acidental do sistema;
- ✓ Obstrução de qualquer parte do sistema.

OBSERVAÇÕES

- ✓ Interromper o procedimento nas seguintes situações:
 - Resistência significativa;
 - Apresentar desconforto e/ou dor intensa;
 - Observar sangramento abundante;
 - Não houver drenagem da urina mesmo após confirmação do posicionamento e relato de sensação de bexiga cheia pelo usuário;
- ✓ A sonda de *foley* deve ser obrigatoriamente trocada toda vez que for manipulada inadequadamente;
- ✓ Em caso de incapacidade de finalizar o procedimento, o usuário deve ser encaminhado para serviço de referência em urologia ou cirurgia geral, para avaliação;
- ✓ Usuários de sonda vesical por cistostomia, residentes de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), devem ter o cuidado compartilhado com a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) de referência. O procedimento pode ser realizado pela equipe de enfermagem do ILPI, porém, não isenta o acompanhamento, registros dos dispositivos e controle de infecção pela equipe da UBSF. O acompanhamento e manejo do idoso é de responsabilidade da equipe da UBSF, e a equipe do ILPI deve participar ativamente do cuidado;
- ✓ Nos casos de sondagem domiciliar, os materiais podem ser descartados na residência do usuário. A equipe deve apenas remover os perfurocortantes;
- ✓ A presença de sinais de infecção no ostoma, não contraindica a troca ou inserção do dispositivo, porém, a equipe médica deve ser informada, para definir condutas para tratamento ou avaliação especializada;
- ✓ A equipe deve orientar usuário e/ou cuidador quanto a realização de curativos, e fornecer material para realizá-lo diariamente.

Orientação ao Usuário e/ou ao Cuidador referente ao manuseio em Domicílio

- ✓ Higienizar as mãos com água e sabão antes e depois de manusear a sonda;
- ✓ Realizar higiene com água e sabão neutro diariamente, durante o banho, no local do ostoma, trajeto da sonda e conexão com a bolsa coletora;
- ✓ Posicionar a bolsa coletora de urina estéril na lateral da cama, cadeira de rodas ou perna, sempre abaixo do nível da cama ou do assento da cadeira. Evitar que a bolsa toque ou permaneça no chão;
- ✓ Clampear a extensão da sonda de *foley* durante a movimentação do usuário (deitar/levantar/mudar o decúbito);
- ✓ Fixar a sonda de *foley* de forma que não a tracione ou exerça pressão nas bordas do ostoma;
- ✓ Desprezar a diurese quando atingir no máximo $\frac{2}{3}$ da bolsa coletora de urina estéril;
- ✓ Realizar novo curativo sempre que estiver molhado ou sujo, ou depois do banho.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde**. Brasília – DF: 2017. Disponível em: <<http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/medidas-de-prevencao-deinfeccao-relacionada-a-assistencia-a-saude>>.
2. CARMAGNANI, Maria I., FAKIH, Trevisani, CANTERAS, Lígia Mara Silva, TERERAN, N. **Procedimentos de Enfermagem** – Guia Prático. 2ª edição. Guanabara Koogan, 04/2017.
3. COLOGNA, adauto J.; **Cistostomia**. Fundamentos em clínica cirúrgica. 3ª Parte Capítulo VI. Medicina, Ribeirão Preto, 2011; 44 (1): 57-52.
4. OLIVEIRA, R. G. de. **Blackbook – Enfermagem**. Belo Horizonte: Blackbook Editora, 2016.
5. POTTER, P. A.; PERRY, A.G.; STOCKERT, P.; HALL, A. **Fundamentos de Enfermagem**. 9ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
6. PREFEITURA DE JOINVILLE. Diretoria de Assistência à Saúde. Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial. **Procedimento Operacional Padrão (POP) Rotina nº 23 – Higienização das mãos**. Joinville – SC: 2023;
7. PREFEITURA DE JOINVILLE. Diretoria de Assistência à Saúde. Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial. **Procedimento Operacional Padrão (POP) Rotina nº 38 – Segregação e acondicionamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)**. Joinville – SC: 2023.

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI): 23.0.209571-0

Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Fernanda Cristina Spiller	Gabriela Cristina da Silva Brandão Manuelle Hölscher Belz	Maristela Mello de Aguiar Vanessa Cardoso Pacheco

Alteração após Revisão

Versão	Data	Responsável	Alteração
02	Jul/2023	Fernanda Cristina Spiller Manuelle Hölscher Belz	✓ Modificação do texto; ✓ Inclusão de informações específicas para coleta de amostra; ✓ Reorganização do texto; ✓ Atualização de conteúdo geral.

